

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
חמד עמאר  
אביגדור ליברמן  
עודד פורר  
יבגני סובה  
שרון ניר  
יוליה מלינובסקי

---

פ/25/6467

### הצעת חוק ביטוח סיעודי ממלכתי (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

1. תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי  
בחוץ ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 –

(1) בסעיף 6(א), אחרי פסקה (12) יבוא :

"(13) השמה במעון של נזקק סיעודי שהגיע לגיל פרישה ;

(14) טיפול ומענה סיעודי קהילתי, לרבות תמיכה וליווי של המטפל העיקרי בנזקק סיעודי." ;

(2) בסעיף 9(ב), אחרי פסקה (1) יבוא :

"(א1) על אף האמור בפסקה (1), עלות מרכיב שירותי הסיעוד בסל תתעדכן מדי שנה בשיעור עליית מדד יוקר שירותי הסיעוד שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובהתחשב בשינויים בגודל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים באותה השנה ; מרכיבי מדד יוקר שירותי הסיעוד ייקבעו בידי שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ושר העבודה, הרווחה והביטחון החברתי ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, ואולם –

(א) 65% לפחות ממדד יוקר שירותי הסיעוד ייקבעו בהתאם לשכר הממוצע במשק ;

(ב) מדד יוקר שירותי הסיעוד לא יושפע מדמי הביטוח הבריאות הנגבים.

(ב1) ההקצאה של עלות הסל לקופות החולים לא תהיה תלויה בדמי הביטוח שיגבה המוסד לביטוח לאומי." ;

(3) בסעיף 13(א)(1), אחרי "בריאות" יבוא "ודמי ביטוח סיעוד" ;

(4) בסעיף 14, בכל מקום, במקום "5%" יבוא "5.75%" ;

(5) בסעיף 15, בכל מקום, אחרי "ביטוח בריאות" יבוא "ודמי ביטוח סיעוד", ובכל מקום, אחרי "ביטוח הבריאות" יבוא "ודמי ביטוח הסיעוד" ;

(6) בסעיף 20(1), בסופו יבוא "ואולם דמי ביטוח סיעוד המשולמים מכוח סעיף 14(ג), ישמשו למטרת סיעוד בלבד" ;

(7) אחרי סעיף 23א יבוא :

#### **"פרק ה'1: השמת נזק סיעודי במעון או במוסד סיעודי**

הגדרות 23ב. בחוק זה –

"זקן סיעודי" ו"זקן תשוש" – כהגדרתם בתקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים), התשס"א-2001<sup>2</sup> ;

"זקן סיעודי מורכב" – אדם הזקוק בנוסף לעזרה בפעולות היום-יומיות גם להשגחה רפואית עקב עירויים קבועים, פצעי לחץ חמורים או עקב התערבויות רפואיות קבועות אחרות ;

"מוסד סיעודי" – מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים נזקקים סיעודיים ;

"נזקק סיעודי" – זקן סיעודי, זקן תשוש, מטופל סיעודי מורכב או תשוש נפש ;

---

<sup>2</sup> ק"ת התשס"א, עמ' 338.

"נזקק סיעודי הזקוק לסידור מוסדי" – מבוטח  
שהגיע לגיל פרישה ומבדיקת קופת החולים  
עולה כי אין שירותים תומכים עבורו  
בקהילה הסמוכה למקום מגוריו או  
ששירותים אלה אינם מספיקים על מנת  
לשמר את רמת תפקודו, וכן מתקיים בו  
אחד מאלה:

(1) בבדיקת מידת התלות בעזרת הזולת  
שערך המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 23ז  
נמצא שהוא תלוי בעזרת הזולת לביצוע  
מרבית פעולות היום-יום או זקוק להשגחה  
קבועה שאינה בנמצא בקהילתו;

(2) נקבע על ידי רופא מומחה בתחום  
הפסיכיאטריה או בתחום הגריאטרי כי הוא  
תשוש נפש;

(3) חוות דעת של המוסד לביטוח לאומי  
קבעה כי אין בסביבתו הטבעית כדי לספק  
מענה הולם לצרכיו מבחינה כלכלית,  
חברתית ותפקודית;

"קהילה סמוכה" – במרחק של עד 20 קילומטרים  
מבית מגוריו של המבוטח או מקום מגוריו בן  
משפחתו, שהוא המטפל העיקרי בו;

"תשוש נפש" – אדם שזקוק להשגחה במרבית  
שעות היממה בשל ירידה במצבו השכלי,  
שנובעים ממנה פגיעה בפעילותו  
הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו  
האינטלקטואלית, כגון ליקוי בתובנה  
ובשיפוט, ירידה ביכולת הזיכרון או חוסר  
התמצאות במקום ובזמן.

זכאות להשמה 23ג. (א) כל מבוטח שהוא נזקק סיעודי הזקוק

לסידור מוסדי יהיה זכאי לקבל מקופת החולים שבה הוא רשום הפניה לאשפוז במוסד סיעודי הקשור בהסכם עם הקופה, בהתאם למצבו התפקודי ובשים לב למצבו הסוציאלי.

(ב) האחריות לאספקת שירותי האשפוז הסיעודי לנזקק סיעודי הזקוק להסדר מוסדי, תהיה על קופת החולים; שירותי האשפוז יינתנו במוסדות שמספקים שירותים בחלוקה לסטטוס זקן סיעודי, זקן תשוש, מטופל סיעודי מורכב ותשוש נפש.

(ג) לא תתקשר קופת החולים עם מוסד סיעודי שלא מתקיימים בו התנאים שעליהם הורה המנהל, לעניין הרמה הרצויה של המוסדות הסיעודיים, לרבות בעניין רמת הטיפול הרפואי, רמת ההשגחה, היקף התשתיות הפיזיות וכוח האדם במקום ואיכותם, היחס כלפי השוהים במוסד ומרכיבים נוספים הנוגעים להפעלה נאותה של המוסד, ולא תבצע בו השמה לפי הוראות פרק זה.

השתתפות עצמית 23ד. (א) מבוטח שהוא נזקק סיעודי הזקוק להסדר

מוסדי וזכאי לאשפוז במוסד סיעודי לפי סעיף 23ג, יידרש לשאת בהשתתפות עצמית במימון האשפוז, שתשולם לקופת החולים.

(ב) קביעת רמת ההשתתפות העצמית תבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם למבחן הכנסה של הזכאי ובן זוגו בלבד.

(ג) שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יקבעו את שיעור ההשתתפות העצמית של המבוטחים במימון האשפוז; בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, סכום ההשתתפות העצמית למבוטח בחודש לא יעלה בכל מקרה על סכום של 4,000 שקלים חדשים; הסכום האמור בסעיף קטן זה יתעדכן בהתאם להוראות סעיף 40א(ז).

### פרק ח'2: עזרה סיעודית קהילתית

הגדרות

23ה. בפרק זה ובפרט 31 לתוספת השנייה –

"ביצוע פעולת יום-יום" – השלמת פעולת יום-יום במלואה;

"גיל פרישה" – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004<sup>3</sup>;

"השגחה" – השגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים;

"זכאי" – מי שמתקיימים בו התנאים לפי סעיף 123;

"יחידת שירות" – מתן שירותי סיעוד כאמור בטור א' ללוח ח'2 לחוק הביטוח הלאומי, בהיקף כאמור בטור ב' לאותו לוח;

"ליקוי" – ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה;

"מטפל עיקרי" – מי שנושא בעיקר נטל הדאגה למתן עזרה רצופה, קבועה ואינטנסיבית בפעולות יום-יום של הזכאי ומנהל את מערכות חייו של הזכאי ללא כל תמורה כספית;

---

<sup>3</sup> ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

"פעולות יום-יום" – קימה ושכיבה, לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, נידות עצמית;

"שירותי סיעוד" – השירותים המנויים בלוח ח'2 לחוק הביטוח הלאומי;

"שעת סיעוד" – טיפול אישי במבוטח בביתו, עזרה בניהול משק ביתו או השגחה עליו, לפי פרט (1) בלוח ח'2 לחוק הביטוח הלאומי;

"שירותי סיעוד אחרים" – שירותים כאמור בלוח ח'2 לחוק הביטוח הלאומי, למעט פרט (1) בו;

"השרים" – שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי.

זכאות לשעות סיעוד<sup>23</sup>. מבוטח שהגיע לגיל פרישה והוא מוגבל בפעולות היום-יום או זקוק להשגחה, רשאי לפנות לקופת החולים בבקשה להכיר בו כזכאי לשירותי סיעוד (בפרק זה – תביעה להכרה במצב סיעודי) והקופה תפנה את בקשתו בצירוף חומר רלוונטי המצוי ברשותה למוסד לביטוח לאומי; קופת החולים רשאית, לפי המלצת גורם רפואי או סוציאלי בקופה להכיר כאמור במבוטח, אף אם לא פנה בבקשה כאמור אם התקיימו התנאים האמורים בסעיף 27(ה).

מבחני תלות וקביעת שיעור הזכאות<sup>23</sup>. (א) המוסד לביטוח לאומי יערוך למבוטח בדיקה לקביעת מידת תלותו בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום-יום או את הצורך שלו בהשגחה (בסעיף זה – רמת תפקוד), לשם קביעת זכאותו לשעות סיעוד.

(ב) בהתאם לבדיקה יסווג המוסד לביטוח לאומי את רמת התפקוד של המבוטח כאמור, באחת מרמות התלות הקבועות בפרט 31 בתוספת השנייה, או שיקבע כי אין הוא תלוי באופן משמעותי בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום או בשל הצורך בהשגחה; תוצאות הבדיקה ונימוקיה ימסרו בכתב למבוטח ולקופת החולים שבה הוא חבר.

(ג) מבוטח זכאי ליחידות שירות בהיקף שייקבע, לפי רמת התלות שבה סווג כמפורט בסעיף 31 לתוספת השנייה, ובהתאם לרמת הכנסתו לפי מבחני ההכנסה שנערכו לו לפי סעיף 23ח.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שמלאו לו 75 שנים רשאי לבחור כי בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת שתיערך לו תבוצע בידי רופא מומחה בגריאטריה, במסגרת עבודתו במוסד רפואי, ובלבד שהמבוטח לא יידרש לשלם ולא ישלם בפועל תשלום כלשהו עבור הבדיקה, להוציא תשלומים החלים על חברים בקופה כמשמעותם בסעיפים 7 ו-8.

מבחני הכנסה  
כתנאי לזכאות  
23ח. (א) בסעיף זה –

"בן זוג" – בן זוגו של התובע הגר עמו;

"ילד" – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי.

"תובע" – מי שהגיש תביעה להכרה במצב סיעודי לפי סעיף 23ח;

(ב) זכאותו של מבוטח ליחידות שירות לפי סל השירותים הבסיסי בהתאם לרמת התלות שנקבעה לו כאמור בסעיף 31 לתוספת השנייה, מותנית במבחני הכנסה לפי סעיף קטן (ב).

(ג) זכאות מלאה כאמור בסעיף קטן (ב),  
תתקיים אם הכנסתו החודשית של המבוטח אינה  
עולה על סכומים כלהלן, לפי העניין:

(1) ליחיד – סכום השווה לשכר  
הממוצע;

(2) מי שיש עמו בן זוג – סכום השווה  
ל-150% מהשכר הממוצע;

(3) למי שיש עמו ילד – סכום נוסף על  
הסכום הקבוע בפסקאות (1) או (2), השווה  
ל-50% מהשכר הממוצע בעד כל ילד.

(ד) עלתה הכנסתו החודשית של המבוטח על  
הסכום כאמור בפסקת משנה (א), יהיה המבוטח  
זכאי למחצית ממספר יחידות השירות.

(ה) בחישוב ההכנסה לפי סעיף זה תובא  
בחשבון הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2  
לפקודת מס הכנסה, אף אם לא צמחה, הופקה או  
נתקבלה בישראל, למעט –

(1) קצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק  
הביטוח הלאומי;

(2) הענקות לחיילים ולבני משפחותיהם  
לפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה  
לעבודה), התש"ט-1949<sup>4</sup>;

(3) גמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות  
שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי;

(4) דמי מחיה לאלמנה או ליתום לפי  
סעיף 144 לחוק הביטוח הלאומי;

(5) קצבה מיוחדת לפי תקנות הביטוח  
הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים  
מיוחדים), התשל"ט-1978<sup>5</sup>;

---

<sup>4</sup> ס"ח התש"ט, עמ' 13.  
<sup>5</sup> ק"ית התשל"ט, עמ' 83.



(6) גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התשי"ע-2010<sup>6</sup>;

(7) גמלה נוספת לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי;

(8) תשלומים לנזקק לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958<sup>7</sup>;

(9) הכנסות משכר דירה למבוטח שמשכיר דירה בבעלותו ומתגורר בדירה שהוא שוכר לצורך מגורים, אולם אם המבוטח מכניס משכר דירה יותר מאשר הוא מוציא, תובא ההכנסה העודפת בחשבון;

(10) הכנסה שמקורה בקצבה חודשית המשולמת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957<sup>8</sup> או מכוח סעיף 3 לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007<sup>9</sup> (בפסקה זו – חוק ההטבות) או המשולמת על ידי מדינת חוץ בקשר עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כגון קצבה כאמור בפסקאות (1) ו-(3) להגדרה "קצבה בשל רדיפות הנאצים" שבחוק ההטבות, קצבה המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה כהגדרתו בחוק ההטבות וקצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו, כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר התקבל בגרמניה ביום 20 ביוני 2002.

---

<sup>6</sup> ק"ת התשי"ע, עמ' 810.

<sup>7</sup> ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

<sup>8</sup> ס"ח התשי"ז, עמ' 163.

<sup>9</sup> ס"ח התשס"ז, עמ' 47.

(ו) על אף האמור בכל דין, במבחני ההכנסה לפי סעיף זה לא יובאו בחשבון הכנסות בן משפחתו של התובע שאינו בן הזוג.

23ט. (א) קופת החולים בה חבר המבוטח שזכאי לשירותי סיעוד, תכין בתאום עם המבוטח ועם המטפל העיקרי, תכנית לקבלת שירותי הסיעוד (בסעיף זה – התכנית), וכן תציע לו את נותן השירותים, בכפוף לזכותו של המבוטח לבחירה מבין נותני השירותים לפי סעיף 23(א).

תוכנית לקבלת  
שעות סיעוד

(ב) לעניין סעיף 3, שירותי הסיעוד לפי פרק זה יינתנו בסמיכות למקום מגורי המבוטח; לעניין זה, "סמיכות למקום מגורים" – מרחק שלא עולה על 20 קילומטרים מבית המגורים של המבוטח, או של בן משפחתו שהוא המטפל העיקרי בו.

(ג) קופת החולים רשאית לקבוע כי התכנית תחול לזמן מוגבל, ותיבחן מחדש מדי תקופה שתיקבע; קופת החולים תנמק את החלטתה לפי סעיף קטן זה ותמסור העתק ממנה למבוטח.

(ד) אספקת שעות הסיעוד לפי התכנית בידי המטפל הסיעודי למבוטח תהיה באחריות קופת החולים ותבוצע באמצעות עובדים מטעמה או באמצעות נותני שירות הקשורים עמה בהסכם.

(ה) קופת החולים תשמש גורם מתאם, מבקר ומפקח על נותני השירותים ואיכות שירותיהם.

(ו) קופת חולים תקיים פיקוח ובקרה על תפקודו המקצועי של נותן שירותי סיעוד אחרים שעמו היא התקשרה, לרבות חברה או עמותת סיעוד; קבעה הקופה כי התאגיד אינו עומד בחובותיו או כי אינו נותן למבוטח שירות ברמה נאותה, תפסיק הקופה את ההתקשרות עמו.

(ז) היה המבוטח מרותק לביתו או מתגורר בגפו, תתייחס התכנית למצבו ותכלול גם מענה רפואי ואישי באמצעות צוות רב תחומי הכולל רופא מומחה לגריאטריה, אחות, עובד סוציאלי, תזונאי, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת ואנשי מקצוע נוספים לשיקול דעתה של קופת החולים.

(ח) השר יקבע את סל השירותים הבסיסי למבוטח זכאי בביתו ובקהילתו, לרבות סוג השירותים הרפואיים והסיעודיים, זמינותם ואיכותם, שבהם תחויב לעמוד קופת החולים או נותני השירות מטעמה.

(ט) קופת החולים אחראית למתן ייעוץ וליווי אישי לכל מבוטח זכאי או נציגו, לפי העניין, כדי לסייע למבוטח למצות את זכויותיו הרפואיות והסוציאליות הנוגעות לטיפול הסיעודי בו מול כל הגורמים לרבות עקב שינוי במצבו הרפואי או הכלכלי.

23. (א) בסעיף זה –

זכאות לתשלום

סכום כספי חלף

שעות סיעוד

”בן משפחה” – הורה, בן זוג, ילד, אח או אחות, וכן בן זוגו וילדו של כל אחד מהם ;

”מטפל סיעודי” – מי שנותן שירותי סיעוד בעצמו, תמורת שכר, ומתקיימים בו כל אלה :

(1) הוא אינו בן משפחה של המבוטח, או שהוא בן משפחה שלו וקופת החולים לא הביעה התנגדות מטעמים רפואיים לכך שיטפל בו ;

(2) אם הוא עובד זר – הוא אינו שוהה שלא כדין בישראל, כמשמעותו בסעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952<sup>10</sup>.

(ב) (1) על אף האמור בסעיף 23ט, מבוטח הזכאי לשירותי סיעוד זכאי לבחור לקבל תשלום חודשי חלף קבלת שעות הסיעוד כאמור בסעיף 23ט.

(2) קופת חולים תבצע הדרכה למטפל הסיעודי המועסק בביתו של המבוטח שבחר בתשלום חלף שעות הסיעוד, לשם טיפול משקם, משמר ומונע, תקיים פיקוח ובקרה על מטפל סיעודי ותקבע אם הוא כשיר ומתאים לטפל במבוטח, בהתחשב בצרכי המבוטח, וכן אם היקף שירותי הסיעוד הניתנים למבוטח בפועל בידי המטפל הסיעודי ורמתם, עונים על צרכיו.

(3) קבעה הקופה כי המטפל הסיעודי אינו כשיר או אינו מתאים לטפל במבוטח או כי שירותי הסיעוד הניתנים למבוטח על ידו אינם עונים על צרכיו, רשאית הקופה לשלול את הזכות לקבל תשלום חלף שעות סיעוד לפי סעיף זה, ובלבד שתספק למבוטח את שעות הסיעוד שהוא זכאי להן בסמיכות וברציפות להפסקת התשלום.

מטפל עיקרי 23יא. קופת החולים תהיה אחראית לקיום קשר שוטף עם מטפל עיקרי במבוטח הזכאי לשירותי סיעוד, לרבות בנושאים האלה –

(1) הדרכה בביתו של הזכאי בנוגע לטיפול בו ;

---

<sup>10</sup> ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

(2) עדכון המטפל העיקרי בעקבות מעקב תקופתי אחר מצבו הרפואי והסיעודי של המבוטח ומתן ייעוץ רפואי וסוציאלי מחודש;

(3) העמדת סל שירותים הכולל טיפול לתמיכה רגשית וליווי מקצועי לרשות המטפל העיקרי;

(4) השתתפות בהוצאה בגין הבראה, פעמיים בשנה, בסכום השווה לקצובת הבראה ונופש בעד 3 ימים המשולמת באותה שנה לעובד המדינה.

בדיקת תלות ובדיקה מחדש 23יב. המוסד לביטוח לאומי יבדוק מחדש לפי בקשתו של המבוטח את תפקודו ומידת התלות שלו, אם חל שינוי במצבו הבריאותי או התפקודי.

זכאות לתקופה מוגבלת 23יג. קופת החולים רשאית לקבוע כי הזכאות לשעות סיעוד ולשירותי סיעוד אחרים תינתן לתקופה מוגבלת שקבעה, כאשר מצבו התפקודי של הזכאי אינו יציב, ובלבד שתנמק את החלטתה בכתב.

סייג לזכאות של מאושפז במוסד 23יד. (א) מבוטח הנמצא במוסד סיעודי לפי פרק ה'1 יחולו עליו הוראות סעיף 307 לחוק הביטוח הלאומי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שאושפז בבית חולים שאינו מוסד סיעודי, יהיה זכאי לשעות סיעוד לתקופה שאינה עולה על 14 ימים ממועד אשפוזו.

חידוש זכאות לאחר 23טו. מבוטח שהופסקה זכאותו לשעות סיעוד בשל כך שאושפז בבית חולים או במוסד סיעודי, ושחרר מאשפוז בתוך תקופה של 90 ימים, או תקופה ארוכה יותר שאישרה קופת החולים, יהיה זכאי לשעות סיעוד ממועד שחרורו, בשיעור שנקבע לגביו טרם אשפוזו.

מניעת כפל זכויות 23טז. הזכאי לשעות סיעוד לפי חוק זה וכן לקצבה מיוחדת לפי סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי או לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיפים 206 ו-206א לחוק האמור, הברירה בידו לבחור באחת מהן.

ועדה לעררים על 23יז. (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת המוסד לביטוח לאומי או קופת החולים לעניין מצבו התפקודי או רמת התלות שלו או תכנית הסיעוד שנקבעה לו רשאי לערור עליה לפני ועדה לעררים בת שלושה חברים המורכבת מרופא מומחה בגריאטריה או ברפואה פסיקלית ושיקום, שהוא יושב הראש, מעובד סוציאלי ומאחות מוסמכת כמשמעותה לפי פקודת בריאות העם, 1940<sup>11</sup>.

(ב) השרים יקבעו רשימת חברים בוועדה לעררים, מבין רופאים מומחים בגריאטריה או ברפואה פסיקלית ושיקום, אחיות מוסמכות ועובדים סוציאליים (בסעיף זה – הרשימה); רק מומחה המועסק על ידי שירותי הבריאות הממלכתיים זכאי להיכלל ברשימה.

(ג) השרים יקבעו הוראות לעניין הרכב הוועדה לעררים, מותביה, סמכויותיה וסדרי עבודתה וכן לעניין המועדים והדרכים להגשת הערר ולדיון בו.

(ד) הוועדה לעררים תתעד את ישיבותיה בפרוטוקול ותמסור למערער העתק לרבות את ההחלטה הסופית על נימוקיה.

(ה) ערעור על החלטת הוועדת לעררים יוגש לבית הדין האזורי לעבודה." ;

(8) אחרי סעיף 25 יבוא :

<sup>11</sup> ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

"מוקד מידע בנושא 25א. קופת חולים תקים מוקד מידע בטלפון ובאינטרנט  
סיעוד שירכו את כל המידע הנוגע לנושאי סיעוד לפי פרק  
ה'2." ;

(9) בתוספת השנייה, אחרי פרט 32 יבוא :

"33. עזרה סיעודית קהילתית :

(1) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 2.5 עד 3 נקודות –  
9 יחידות שירות לשבוע ;

(2) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 3.5 עד 4.5 נקודות  
– 10 יחידות שירות לשבוע ;

(3) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 5 עד 6 נקודות – 17  
יחידות שירות לשבוע ; ואם הוא מעסיק עובד זר בענף הסיעוד –  
14 יחידות שירות לשבוע ;

(4) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 6.5 עד 7.5 נקודות  
– 21 יחידות שירות לשבוע ; ואם הוא מעסיק עובד זר בענף  
הסיעוד – 18 יחידות שירות לשבוע ;

(5) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 8 עד 9 נקודות – 26  
יחידות שירות לשבוע ; ואם הוא מעסיק עובד זר בענף הסיעוד –  
22 יחידות שירות לשבוע ;

(6) מבוטח שנקבעו לגביו בבדיקת התלות 9.5 עד 10.5 נקודות  
– 30 יחידות שירות לשבוע ; ואם הוא מעסיק עובד זר בענף  
הסיעוד – 26 יחידות שירות לשבוע ;".

תיקון חוק הביטוח 2. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995<sup>12</sup> –  
הלאומי

(1) סעיפים 223 עד 236 – בטלים ;

(2) בסעיף 320 –

(א) סעיף קטן (ב) – בטל ;

(ב) בסעיף קטן (ו), פסקה (6) – תימחק ;

<sup>12</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(3) בלוח ח', בפרט (ז) –

(א) בפסקה (1), במקום פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ג) מבוטח הזכאי לשירותי סיעוד לפי פרק ה'2 לחוק ביטוח בריאות";

(ב) בפסקה (2), אחרי פסקת משנה (ה) יבוא:

"(ו) מחלקה ייעודית בקופת החולים שתפקידה מתן מענה ושירות למבוטחים סיעודיים."

(4) בלוח י"ז, בפרט 46 –

(א) במקום האמור בטור א' יבוא "זכאות לשירותים לפי פרקים ה'1 או ה'2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי";

(ב) במקום האמור בטור ב' יבוא "סעיפים 23ג ו-23ח לחוק ביטוח בריאות".

תחילה והוראות 3. (א) תחילתו של חוק זה ביום \_\_\_\_\_\* (להלן – יום התחילה). מעבר

(ב) הסכום שיוקצה מתקציב המדינה לטובת ביטוח סיעודי ממלכתי, לרבות תשושי נפש, לא יפחת מסכום שהוקצה כאמור ערב תחילתו של חוק זה; לאחר כניסת חוק זה לתוקפו יישמר ערכו הריאלי של הסכום בהתאם למדד יוקר שירותי הסיעוד כמשמעותו בסעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ולגידול באוכלוסייה.

(ג) בתקופה שעד ערב יום התחילה, ישמשו הסכומים הנגבים כדמי ביטוח סיעוד להגדלה של גמלת הסיעוד המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

---

\* המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.



(ד) השרים, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, יעדכנו עד ערב יום התחילה את העדכונים הנדרשים בכללי ההקצאה לפי סעיף 17(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, ככל שהדבר נדרש לצורך הביטוח הסיעודי הממלכתי לפי חוק זה, לנוכח המצב בפועל ובשים לב למאפייני החברים בקופות החולים, וביניהם: גיל המבוטחים, שיעור המבוטחים המבוגרים ביותר מתוך כלל החברים בקופה, מגדר, מצב סוציו אקונומי והמיקום הגאוגרפי.

## דברי הסבר

המדיניות שבאה לביטוי בחוקים שונים וביניהם חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), היא לסייע לקשישים הנזקקים לעזרה סיעודית, אם בקהילה ואם באשפוז.

אוכלוסיית הקשישים היא אוכלוסייה חלשה וענייה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. כמו כן, לאור הגידול בתוחלת החיים, צפויה אוכלוסייה זו לגדול משמעותית בשנים הקרובות, והתקופה שבה הקשישים מתקיימים מקצבאות או מפנסיה מתארכת.

כיום ישנם מספר מוקדים בעייתיים ולא יעילים אשר בכוונת הצעת חוק זו לטפל בהם. ראשית, הנטל הכלכלי המוטל על משקי הבית בשל הכיסוי הביטוחי הלא מספק אל מול הצרכים. שנית, הפיצול הרב של מבטחים ונותני שירות: המוסד לביטוח לאומי בנוגע לגמלאות סיעוד בקהילה, משרד הרווחה והביטחון החברתי בנוגע להשמת זקנים תשושים במעונות, משרד הבריאות בנוגע לאשפוז גריאטרי כרוני, וקופות החולים ביחס לגבי מטופל סיעודי מורכב ולגבי סוגי אשפוז וטיפולים רפואיים נוספים. פיצול זה מוסיף לסרבול בטיפול בקשישים, מטיל נטל רב עליהם ועל בני משפחותיהם וגורם להעדר תמריצים מספיקים לגורמים המטפלים לפעול לשיקום ושימור מצבם של קשישים, להשאתם בקהילה ולמניעת הידרדרות מצבם הרפואי והתפקודי.

ריבוי התחלואה וחוסר העצמאות המאפיינים את הקשיש הזקוק לעזרה סיעודית מחייבים טיפול בידי צוות רב-תחומי, תוך תיאום בין הגורמים המטפלים, ניהול נכון וקיומו של מערך תומך. הניתוק הקיים כיום בין גורמים טיפוליים והפיצול בין המשרדים האחראים פוגע באיכות הטיפול הרפואי-סיעודי בקשישים, מביא לחוסר אחידות בקריטריונים, לעומס כלכלי, רגשי ובירוקרטי על המשפחות, לתמריצים הפועלים בכיוונים שאינם לטובת הקשיש, לכפל עלויות ולחוסר יעילות.

דוח מבקר המדינה מס' 61' לשנת 2010 הצביע על ליקויים בכל הקשור לטיפול בצרכי הקשישים בקהילה ובמוסדות האשפוז. בהמלצותיו המליץ המבקר לקדם שינויי חקיקה שיתאימו את מספר שעות הטיפול הניתנות לקשיש למידת תלותו בזולת, ולהבטיח שהזכאים אכן יקבלו את מלוא גמלת הסיעוד כקבוע בחוק. כמו כן, המליץ המבקר למשרד הרווחה והביטחון החברתי, למוסד לביטוח לאומי ולמשרד הבריאות, לבחון את תהליך בחינת הזכאות לגמלת הסיעוד, להגדיר מחדש את תפקידיהן של הוועדות המקומיות-מקצועיות, לקבוע כללים בנוגע לביקורי העובדים המקצועיים בבתי הקשישים ולהקפיד על

ביצועם בתדירות המתחייבת על מנת לפקח ביעילות על טיב שירותי הסיעוד הניתנים לקשישים. לאור כל האמור לעיל וכדי להגביר את היעילות באספקת השירותים לאוכלוסייה חלשה זו מוגשת הצעת חוק זו, לשם השגת המטרות הבאות: הבטחת כיסוי אוניברסלי בהיקף ראוי ובר קיימא לאורך שנים, הגברת היעילות של מערך אספקת השירותים לנזקקי סיעוד, שיפור הנגישות ואיכות שירותי השיקום והסיעוד לנזקק ומשפחתו, עידוד הטיפול הסיעודי במסגרת הקהילה והעצמת יכולת ההתמודדות של המשפחה, הגברת היעילות של פעילות הרגולציה והאכיפה, היערכות להתפתחויות עתידיות בתחום תשתיות הטיפול בחולה הסיעודי ושיפור הידע ושקיפות המידע למבוטחים.

מוצע לקבוע שמשדד הבריאות ישמש כגורם האחראי על מגוון הטיפולים הרפואיים-סיעודיים בקשיש הנזקק לסיעוד, וקופות החולים יוגדרו כגורם האחראי על אספקת השירותים וניהולם, במתכונת דומה לזו שבה פועלות הקופות כיום בכל הקשור לשירותי בריאות שבחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

באופן זה ינוצלו תקורות קיימות בקופות החולים וינוצל הניסיון הניהולי העשיר שלהן באספקת שירותים בקהילה. כמו כן, יביא הדבר לקיומו של רצף טיפולי בקשיש, עם תמריץ להשקיע ברפואה מונעת ומשקמת, והשארת המבוטח בקהילה בקרב משפחתו, כל עוד הדבר אפשרי.

מוצע כי האחריות הכוללת למתן טיפול סיעודי לקשישים נזקקי סיעוד בקהילה ובמוסדות תועבר לקופות החולים, באמצעות העברת האחריות למתן שעות סיעוד בבית, במקום גמלת סיעוד, מהמוסד לביטוח לאומי אל קופות החולים.

עוד מוצע להרחיב את הזכאות של נזקקי הסיעוד לשירותים במימון ציבורי, ולהעביר את האחריות הביטוחית על נזקקי הסיעוד, תשושים, תשושי נפש וסיעודיים מורכבים, בין בקהילה ובין באשפוז לידי קופות החולים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/3451) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4669), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2662) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום (פ/25/1736); הוסרה מסדר היום ביום י"ב בחשוון התשפ"ה (13 בנובמבר 2024), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/4169) ועל ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/25/4792). הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת יונתן מישרקי וארז מלול (פ/25/4829).

הצעת החוק זהה לפ/25/4829 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)